

如何照顧思覺失調症患者

前言

思覺失調症的病人發病，常常是慢慢進行的。起先只覺得病人開始出現一些較不尋常的行為舉止，病人自己也都可以說出一些可以接受的理由，但是漸漸地隨著病程變化，病人的一些不尋常的行為舉止或言行，變得更多，變得更離譜，甚至與現實生活情境或邏輯背離。



病人除了會說一些奇怪聽不懂、別人無法理解的話之外，也常常有一些莫名其妙的想法或念頭，甚至會相信一些在別人眼裡覺得荒誕不經的事情(亦即所謂的妄想)。

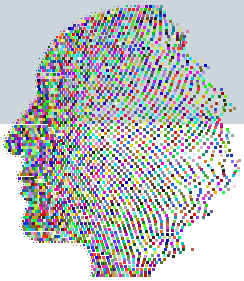
當病人有幻聽時，怎麼辦？

病人常抱怨耳朵聽到多人說話的聲音，有的在讚美他，有的在批評他或命令他做一些事，使得病人出現無法專心與他人交談，常自言自語，傻笑或自哭，甚至因而出現一些怪異的行為。

◎處理方法有：

1. 此為病人的幻聽症狀表現，不要批評，也不要責罵病人的症狀。
2. 家人可鼓勵病人說出來，並設身處地的接受他的情緒感受。
3. 轉移病人對幻聽的注意力，可建議病人聽音樂、看電視、做戶外活動。
4. 明顯的幻聽干擾以致出現暴力或自殘的傾向時，需儘速送醫。
5. 當病情趨穩定時，可協助病人去區分幻聽與真實的聲音。





當病人有妄想時，怎麼辦？

所謂妄想是指不合現實的想法，而且當事人堅信不移，例如:有的病人深信大家都要害他及跟蹤他，但事實上並不是如此。

◎處理方法有：

1. 此為病人的妄想症狀，不批判、不爭辯，也不強化或附和。
2. 妄想還不至於影響到病人或家人安全時，家人可採取傾聽的態度，讓病人說出他心裏的想法，接受他的不安感受。
3. 妄想已明顯影響到病人的日常生活，則儘速送醫。
4. 待病情穩定時，再與病人討論不合現實的想法，以增強現實感。

當病人有攻擊行為時，怎麼辦？

當病人出現眼露兇光、緊握雙拳、突然雙眼凝視一處不動、言語激動、坐立不安，這些可能是出現暴力的前兆。

◎處理方法有：

1. 周遭人更需要保持冷靜，可以用溫和的態度，問病人「因為何事而生氣呢?」，鼓勵病人以言語表達來疏解心中的情緒。藏好周遭危險物品（如：刀子、剪刀、有毒性的物品）。
2. 病人持續過度激動且無法控制時，以肯定而溫和的語氣告訴病人，大家都不喜歡他這麼做，倘若仍無效，有造成傷害之虞，則家人可合力暫時用布條或床單約束病人四肢，同時向病人說明如此做是為了保護他及使他不受到傷害，之後儘快送醫。

如何協助病人服藥呢？

病人大多不認為自己生病而拒絕服藥，這點使得家屬與醫護人員深感無力，病人也常因長期服藥感厭煩而停藥。

◎處理方法有：



1. 讓病人知道自己為何要吃藥，吃什麼藥。
2. 與治療的醫師討論服藥的方式或副作用。
3. 將藥物分別包好，放在病人容易注意的地方。
4. 在病人服藥後，予以讚美或獎賞。
5. 當病人拒絕服藥時，需與醫師聯絡，考慮改用長效針劑或滴劑。

病人出現明顯干擾的藥物副作用，怎麼辦？

通常病人感到最痛苦的藥物副作用，為眼球上吊、肌肉僵硬致斜頸、舌頭吐出，若出現以上不適，可與主治醫師討論，經處理後很快可得到緩解。

病人的疾病失控了，怎麼辦？



1. 家人更要保持鎮靜，試著安撫病人的情緒。
2. 若病人仍激動不已，出現「明顯傷害他人或自己，或有傷害行為時」，可請警察機關協助送醫。
3. 其他協助就醫方式：自己找人幫忙、找救護車中心幫忙、或與照顧過的主治醫師聯絡。

如何協助病人工作？

1. 病人病情穩定，有明顯的工作動機時，可到醫院的日間留院、社區復健中心或庇護性工作場，接受工作之訓練，養成工作習慣、培養敬業的工作態度，訓練社交技巧能與團隊相處。
2. 當以上訓練已有一定的成果，欲嚐試工作，可先從壓力較小的自家或親友開的公司內幫忙。
3. 當以上壓力較小的工作適應良好，才進而考慮外出正式工作，先以單純的人際關係、競爭小、或較機械化的工作為主。一步一腳印及按步就班，工作機會仍大，不但有自信，也有成就感。